Scouts du Sénégal
Région de Dakar
Branche Verte

Secourisme

P LAN

I/ Définition

II/ Que faire face à un accident: Les 3 temps

1- Protéger
2- Alerter
3- Secourir
   a) Examen d'une victime
   b) Gestes d'urgence
   c) Surveillance

III/ Les 10 règles du secouriste

IV/ Boîte à pharmacie

V/ Quelques notions

XL DKR

I/ Définition

Le secourisme peut être définit comme un ensemble de moyens techniques et thérapeutiques constitués par les premiers gestes d'urgence et visant à aider une ou des victime(s) avant l'arrivée des secours. Il est de même un état d'esprit pratique d'intervention, car résultant d'une pratique opérationnelle maitrisée et sans cesse perfectionnée.
Etre secouriste c'est savoir porter secours efficacement avec **un rôle primordial, limité et temporaire.**

II/ Que faire face à un accident

En cas d'accident, il faut respecter les 3 temps du secourisme :

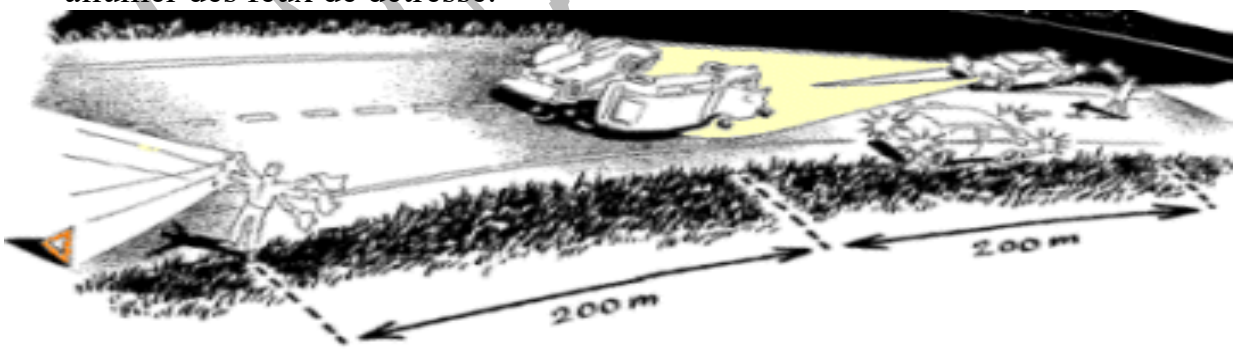
1- Protéger

♣ Définition

La protection vise à prévenir un autre danger (sur-accident). Le secouriste se protège, protège en même temps la/les victime(s) et les tiers (les témoins). La protection doit être immédiate, adaptée, suivant les circonstances mais également permanente (protection fiable et durable).
Pour réaliser la protection, utiliser tous les moyens matériels dont on peut disposer mais aussi humains en s'assurant de la participation de toute personne apte qui pourrait apporter une aide dans la mise en œuvre de cette protection.

Exemples de protections :

- Baliser : dans le cas d'un accident de circulation en plaçant des triangles de pré-signalisations à une distance de 100 à 150m pendant la journée et 200m pendant la nuit dans les deux (2) sens de la circulation ; si possible allumer des feux de détresse.



- Dégager : S'il y a des risques de sur-accident réels et non maitrisables, le secouriste doit soustraire rapidement la victime du danger sans y succomber.
- En cas de danger électrique : couper le courant avant de toucher la victime
- S'il y a risque d'explosion par fuite de gaz, ne pas provoquer d'étincelles (allumettes, interrupteurs, etc.) ; il faut **aérer** : ouvrir portes et fenêtres.

♣ **Dégagement d'urgence de la victime de la zone dangereuse en toute sécurité**

Devant l'impossibilité de supprimer le danger et si la victime est incapable de se soustraire elle-même au danger, dégager la victime le plus rapidement possible. Le dégagement d'urgence est une manœuvre éventuelle qui ne doit être utilisée que pour soustraire une victime à un danger vital, réel, immédiat et non contrôlable. Dans cette situation, le dégagement est considéré comme une protection, car elle permet d'éviter un autre accident. **Mais cette manœuvre peut être dangereuse pour une victime atteinte d'un traumatisme.**

TECHNIQUES

- traction par les chevilles
- traction par les poignets
- traction par les aisselles
- dégagement de la victime d'un véhicule
- dégagement en relais : elle est réalisée par au moins 2 secouristes, lorsque la victime n'est pas visible en totalité (sous un véhicule, …).
- ramassages ou relevages
  -relevage en « cuiller »
  -le coup du pompier
  -relevage en position demi assise
  -brancardage : recommandé surtout en cas de traumatisme ; les atteintes des os et articulations doivent être bien immobilisées au préalable.

IMPORTANT :

- Pour protéger, effectuer une approche prudente de la zone de l'accident pour bien analyser les risques et cibler les personnes à protéger ;
- En cas d'accident de véhicules, couper le contact si possible ;
- Ne pas fumer et ne pas laisser fumer : risque de feu ou d'explosion
- En cas d'immobilisation du véhicule vers un virage, le triangle doit être positionné dans les 2 sens de la circulation, mais surtout avant le virage pour que les véhicules qui viennent du côté du virage soient prévenus avant de tourner.
- pour procéder à un dégagement d'urgence, il faut respecter l'axe « tête-cou-tronc ».

2- Alerter

L'alerte est l'action qui consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une situation nécessitant le recours à leur service, ainsi que la situation générale des faits. Dans ce contexte, ne pas alerter les services d'urgence, ou leur donner des informations erronées ou incomplètes, peut compromettre la vie ou la santé d'une victime malgré les premiers secours assurés par un sauveteur.
En ville, alerter : les Sapeurs-Pompiers (18), ou le SAMU (1515) et la Police (17).
En campagne : les Sapeurs-Pompiers(18) et la Gendarmerie (800 00 20 20).

COMMENT ALERTER

Il faut d'abord garder son calme et s'exprimer avec clarté et précision.
L'appelant doit pouvoir donner les indications suivantes:
- Son nom et numéro de téléphone;
- Localisation très précise de l'événement ;
- Nature du problème (accident de la route, feu, noyade…) ;
- Nombre de victimes et état apparent de chaque victime ;
- Risques éventuels ;
- Premières mesures prises et gestes effectués.

NB: Ne pas raccrocher sans autorisation.

Avant l'arrivée des secours, si le secouriste est seul, il peut alerter et demander une aide en criant au secours, en téléphonant, en agitant un linge pour se faire voir, etc.

3- Secourir

Secourir c'est porter assistance à une personne en danger ; le danger étant ce qui menace ou compromet l'existence d'une personne.

A) Examen de la victime

C'est le coup d'œil, l'analyse qui sauve. Il doit se faire rapidement et permet de connaitre l'état de la victime avant d'agir. Il faudra savoir :

- ♣ Si la victime respire ou non ➔ Si aucun mouvement de la poitrine ni de l'abdomen n'est visible et aucun souffle n'est perçu, elle ne respire pas
  - Se pencher sur la victime, l'oreille et la joue du sauveteur au-dessus de sa bouche et de son nez, son menton élevé tout en regardant si ses poumons et son ventre s'élèvent et s'abaissent.
- ♣ Si la victime saigne ➔ une hémorragie est l'écoulement non contrôlé du sang hors des vaisseaux sanguins. On distingue 3 types d'hémorragies :
  Hémorragie externe=> C'est lorsque l'écoulement du sang se produit à l'extérieur du corps (on voit le sang).
  Hémorragie interne=> C'est l'écoulement du sang à l'intérieur du corps.
  - ❖ Signes: Pouls rapide ou imprenable, extrémités froides (mains…), ventre grossi, peau moite et froide, saignement du nez ou des oreilles, soif intense, respiration anormale, perte graduelle de l'état de conscience, nausées et vomissements, etc.

  Hémorragie extériorisée=> C'est une hémorragie interne qui s'extériorise par les orifices naturels (nez, oreille, bouche, les parties génitales, anus).
- ♣ Si la victime est inconsciente ➔ Une victime inconsciente est une personne qui a perdu toute capacité relationnelle. Elle ne répond pas aux ordres simples, …
  - Apprécier l'état de conscience en lui donnant des ordres simples ou en secouant l'épaule de la victime. Si elle ne réagit pas elle est inconsciente.

♣ Si la victime présente un traumatisme des os ou des articulations ➔
-Une fracture est la cassure de l'os complète ou incomplète.

- Signes : Déformation, gonflement, douleurs, enfoncement, impotence fonctionnelle (incapable de remuer le membre blessé)
  - ➢ Fracture ouverte : elle est dite ouverte s'il y'a une plaie (l'os perce la peau) et les dangers sont: infection locale, hémorragie, etc.
  - ➢ Fracture fermée: la fracture est fermée si l'os ne perce pas la peau

-Une **luxation** est un déboîtement de l'articulation. Ce sont des lésions des ligaments (étirement ligamentaire) d'une articulation où la tête de l'os sort de sa cavité ou boîte articulaire. Elles surviennent le plus souvent au niveau de l'épaule, mais peuvent aussi survenir au niveau du coude ou du genou.

- Signes : Enflement ; le membre devient plus long ; douleur ; perte de la mobilité.

-Une **entorse** correspond à un étirement ou à une déchirure des ligaments qui maintiennent en place une articulation. C'est une lésion articulaire causée par un étirement des ligaments sans déplacement osseux et les parties plus touchées sont les chevilles et les genoux.

- Signes : Enflement ; douleurs ; difficiles de remuer la partie blessée.

♣ Si la victime présente une plaie ➔ la plaie est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec atteinte possible des tissus sous la peau.

♣ Si la victime présente une brûlure ➔ une brûlure est une lésion de la peau et éventuellement des tissus sous-jacents, provoquées par la chaleur, une substance chimique, l'électricité, un frottement, ou des radiations…

Brûlures du 1er degré=> elle est provoquée en général par le frottement (c'est l'épiderme qui est atteint)

Brûlures du 2nd degré=> il s'agit d'apparition sur la partie brulée de cloques de grosseurs variables remplies de liquide clair (c'est le derme qui est atteint)

Brûlures du 3e degré=> il s'agit d'une brûlure qui dépasse la peau et qui atteint les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et parfois même les os

♣ Si la victime s'étouffe ➔ le mouvement de l'air entre l'extérieur et les poumons est complètement empêché du fait d'une obstruction totale des voies aériennes.

B) Gestes d'urgences : Conduite à tenir (CAT)

♣ **La victime saigne**

CAT Hémorragie externe:

1- Arrêter l'hémorragie par une compression manuelle locale tout en prenant garde de ne pas être en contact direct avec le sang (porter des gants ou intercaler entre la main et la plaie un tissu propre ou imperméable…).
2- Allonger la victime et surélever le membre atteint
3- Le couvrir et le protéger des intempéries

4- Si l'hémorragie ne s'arrête pas suite à la compression manuelle locale, faire un pansement (compresse + bandage : renouvelable) puis appuyer encore ; si ces derniers sont inefficaces il faut faire les compressions à distance à travers les 5 points de compression à distance (endroit privilégié du corps où l'on peut plaquer l'artère sur un plan osseux).

Compression à distance

Cette compression n'est faite que lorsque :
- la compression directe sur la plaie est inefficace et le sang continue de couler ;
- la compression directe sur la plaie est impossible en cas de : fracture ouverte, fracture compliquée, plaie inaccessible ou avec un corps étranger que l'on ne doit jamais retirer (risques d'aggraver la lésion) ;
- le sauveteur présente une plaie des mains et ne possède pas de moyens de protection.

Techniques : il faut assurer une compression du vaisseau qui est la principale source de l'hémorragie entre le cœur et la plaie qui saigne.
Le point de compression s'effectue :
-au pli de l'aine, pour les saignements du membre inférieur ;
-sur la face interne du bras pour les saignements du membre supérieur ;
-à la base du cou pour une plaie de la tête ou du visage;
-sous la clavicule pour une plaie du cou ;
-sur la face interne de la cuisse pour les saignements du membre inférieur.

Le garrot

Le garrot est un moyen d'arrêt de l'hémorragie à distance fait par un lien ; il n'est utilisé qu'en cas de force majeure (risque de gangrène puis d'amputation)
-les compressions sont inefficaces et le sang continue de couler ;
-les compressions ne peuvent être maintenues par un sauveteur isolé qui doit donner l'alerte ou qui doit s'occuper de plusieurs victimes ;
-en cas de membre incarcéré (membre surchargé) ;
-en cas de plaie sèche ou de membre amputé ;
-impossibilité de réaliser les compressions du fait de la position de la victime ;
Le garrot est mis en place entre la plaie et le cœur. Il doit être réalisé avec un lien large : cravate, écharpe, foulard, jamais avec une ficelle, un fil de fer ou un garrot élastique pour éviter un cisaillement du membre.
NB : ***Le garrot doit toujours rester visible : ne jamais couvrir la partie où est posé le garrot. L'heure de pose du garrot doit être relevée et toujours marquée de façon claire et visible sur la victime***. *Une fois posé, seul un médecin est autorisé à l'enlever et on évacue la victime en 1ere urgence*.

CAT Hémorragie interne

1- Allonger la victime
2- Faire une autotransfusion
3- Ensuite la mettre en position de choqué
4- La couvrir et Evacuer (en position de choqué)
5- Ne pas donner à boire

CAT Hémorragie extériorisée

- Saignement du nez ou Epistaxis
  1. Faire assoir le blessé (ne pas l'allonger pour éviter qu'elle avale son sang)
  2. Pencher sa tête en avant, l'incliner vers le bas
  3. Comprimer avec le pouce (ou lui demander de comprimer) la narine qui saigne. Si ce sont les 2narines, il faut demander à la victime de respirer par la bouche ;
  4. Si le saignement persiste évacuer rapidement la victime, la tête penchée en avant
- Saignement de l'oreille ou Otorragie
  1. Couvrir l'oreille qui saigne
  2. Evacuer la victime, la tête penchée vers l'oreille qui saigne
- Vomissement de sang ou Hématémèse
  1. PLS
  2. Diète absolue
  3. Evacuation de la victime tout en récupérant ces vomissures et en la couvrant
- Crachat de sang ou Hémoptysie
  1. Position demi-assise
  2. Diète absolue
  3. Evacuation de la victime tout en récupérant les crachats
- Saignement des organes génitaux

Outre que les règles menstruelles des femmes, tout saignement des organes génitaux doit être évacué d'urgence.

NB :

- Pendant toute la réalisation de la CAT, expliquer à la victime ce qui se passe pour la réconforter et rechercher sa coopération.

-Des maladies peuvent être transmises par le sang en cas de plaie même minime des mains du sauveteur (donc il faut se protéger). Après l'action de secours se laver les mains, les désinfecter et retirer les vêtements souillés de sang le plus tôt possible.

♣ **La victime ne respire plus**

CAT :

1- Placer la victime sur le dos si elle n'est pas déjà dans cette position ;
2- Assurer immédiatement la LVA :
   *desserrer ou dégager tout ce qui peut gêner la respiration et la circulation (ceinture, boutons, cravate, col).
   *basculer doucement la tête de la victime en arrière et élever le menton
   *retirer les corps étrangers visibles à l'intérieur de la bouche de la victime s'il y en a avec la main qui tenait le front.

1e cas : Difficulté respiratoire → C.A.T → L. V. A + surveillance

WIDER

2e cas : Arrêt respiratoire C. A. T. → L. V. A. + V. A.
3e cas : Arrêt cardio-respiratoire C. A. T. → L. V. A. + M. C. E. + V. A.
4e cas : Obstruction des voies aériennes C. A. T. → La méthode de HEIMLICH

NB : Si les signes de circulation (dont la respiration), sont présents, installer la victime en PLS et surveiller en permanence sa respiration. **Si les pouls carotidiens sont perçus sans la respiration, effectuer uniquement la ventilation artificielle.** Si la respiration s'arrête de nouveau, remettre la victime sur le dos et recommencer la RCP.

Techniques de ventilation artificielle sans matériel

*le bouche-à-bouche
*le bouche-à-nez
*le bouche-à-bouche et nez (généralement pour les bébés ou les enfants)

♣ La victime est inconsciente

CAT :

1- Si la victime ne respire pas, appliquer la même méthode que la précédente (Cf. la victime ne respire plus)
2- Si la victime est inconsciente mais elle respire, la mettre en position latérale de sécurité (PLS) ;
3- Rechercher toute détresse évidente qui peut menacer la vie (saignements) ;
4- Contrôler la respiration et l'état de conscience de la victime en attendant les secours.

♣ La victime présente un traumatisme des os ou des articulations

⅄ Traumatisme du dos, de la tête ou de la nuque

C.A.T. :

1- Ne pas faire bouger la victime ;
2- Conseiller fermement au blessé de ne faire aucun mouvement en particulier de la tête ;
3-Faire alerter les secours d'urgence ;
4- Maintenir la tête avec les 2 mains placées de chaque côté de celle-ci, le sauveteur est à genoux derrière le blessé ;
5- Surveiller la victime de manière continue, lui parler.

⅄ Traumatisme de membres

C.A.T. :

1- Immobiliser le membre traumatisé ;
2- Alerter les secours ou demander un avis médical ;
3- Respecter les recommandations données par les secours ;
4- Surveiller la victime en lui parlant régulièrement et le protéger du froid (éventuellement).

⅄ C.A.T. : LUXATION OU DEBOITEMENT

1- Ne pas essayer de remettre l'os à sa place (si l'on n'est pas formé à cela)

2- Immobiliser en soutenant l'articulation à l'aide d'une écharpe (membre supérieur) ou des attelles (membres inférieur)
3- Alerter ; à défaut, si le membre est bien immobilisé, il faut évacuer vers une infirmerie ou un hôpital proche en évitant de le faire bouger.

- C.A.T. : ENTORSE
  1- Appliquer des bains froids (pansements froids) ;
  2- Ne pas retirer les chaussures (elle sert d'attelles et empêche l'enflure) ;
  3- Immobiliser en évacuant.

♣ **La victime présente une plaie**

***Plaie simple** :

Petite coupure de la peau ou éraflure ou piqûre superficielle

CAT :

1- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ;
2- Porter des gants à usage unique ;
3- Nettoyer la plaie avec une compresse et un antiseptique (dakin) en allant du centre vers l'extérieur;
4- Protéger la plaie par un pansement (la plaie risque d'être à nouveau infectée) ;
5- Demander à la victime si elle est vaccinée contre le tétanos (éventuel par rapport à la cause de la plaie) et voir si ça remonte à plus de 10ans ;
6- Si la plaie devient chaude, si elle gonfle ou si elle continue de faire mal dans les 24h, consulter un médecin.

NB : - On ne nettoie pas une plaie avec du coton ;
- On ne met pas d'alcool dans une plaie.

***Plaie grave :**

C'est quand la plaie dépasse la peau. Elle est profonde, large, étendue.

CAT :

1- Identifier la gravité de la plaie ;
2- Demander rapidement un avis médical (alerter) ;
3- Installer la victime en position d'attente :
- Plaie de la poitrine (du thorax) : position demi-assise ;
- Plaie de l'abdomen : position couchée sur le dos, jambes repliées.
- Plaie de l'œil :
  -allonger la victime à plat dos ;
  -lui demander de fermer ses yeux et de ne pas bouger sa tête ;
  -ne jamais retirer un corps étranger de l'œil et de n'importe quelle plaie.

4- Protéger la victime du froid, de la chaleur ou des intempéries ;
5- Parler régulièrement à la victime pour la réconforter.

♣ **La victime présente une brulure**

- **Brûlures du 1er degré**

CAT :

1- Supprimer la cause ou soustraire la victime à la cause ;
2- Refroidir le plus tôt possible la brûlure avec de l'eau tiède sans pression pendant 5 à 10mn généralement (cela diminue l'extension de la brûlure et soulage la douleur)
3- Appliquer si possible, un gel apaisant, hydratant et antiseptique pendant un ou deux jours.

- **Brûlures du 2nd degré (superficiel ou profond)**
  1- Supprimer la cause ou soustraire la victime à la cause ;
  2- Refroidir le plus tôt possible la brûlure avec de l'eau sans pression pendant 5 à 10mn généralement ;
  3- Désinfecter la zone brulée à l'aide d'une solution antiseptique
  4- Protéger la brûlure par un pansement adapté, ne pas percer la cloque
  5- Ne pas hésiter à consulter un médecin surtout pour une brûlure du 2e degré profond
- **Brûlures du 3e degré**
  1- Supprimer la cause ou soustraire la victime à la cause ;
  2- Alerter les secours ;
  3- Refroidir le plus tôt possible la brûlure avec de l'eau tiède ;
  4- Retirer les vêtements de la victime le plus tôt possible sans ôter ceux qui sont collés à la peau ;
  5- Allonger le brûlé sur le côté non brûlé, si possible sur un drap propre et s'il le brûlé ne présente pas de gênes respiratoires ;
  6- Surveiller la victime
     - Si elle est consciente, la réconforter
     - Si elle ne répond pas, pratiquer les gestes qui s'imposent.

En somme, pour certains cas graves du 3e degré: Emballer – Etiqueter – Evacuer

Brulures électriques

- Ne pas toucher la victime avant d'être sûr que tout risque électrique soit écarté ;
- Alerter les secours et suivre les conseils donnés.
- Arroser la zone brulée visible, à l'eau courante (tempérée 15-25°)

Si c'est du courant électrique domestique :

- Couper d'abord le disjoncteur ;
- Porter des chaussures à semelles en caoutchouc ;
- Dégager le fil électrique avec un bâton sec ;
- Soustraire la victime de la cause ;
- Emballer les parties atteintes avec un linge propre si la victime est brulée ;
- Faire la réanimation en cas d'arrêt cardio-respiratoire (La Méthode de Réanimation: Sylvester avec billot) ;
- Mettre la victime en position confortable et Evacuer.

Si c'est du courant de haute tension :

- Alerter rapidement la société nationale d'électricité (SENELEC) et les Sapeurs-Pompiers éventuellement.

♣ **La victime s'étouffe** :

CAT :

1- Laisser la victime dans la position où elle se trouve (habituellement debout ou assise) ;
2- Constater l'obstruction totale ou partielle des voies aériennes ;
3- Désobstruer les voies aériennes en lui donnant 5 claques sur le dos ;
4- En cas d'inefficacité des claques sur le dos, réaliser 5 compressions abdominales selon la méthode décrite par HEIMLICH ;
5- Constater l'efficacité des claques sur le dos ou des compressions abdominales (vérifier si le corps étranger est visible dans la bouche de la victime pour pouvoir l'extraire soigneusement).

Après expulsion du corps étranger, le sauveteur doit parler à la victime, la réconforter et demander un avis médical.

Si l'obstruction persiste malgré tout, réaliser à nouveau ce qui a été fait (5 claques sur le dos et 5 compressions abdominales) et faire alerter si ça persiste.

EXAMEN D'UNE VICTIME : RESUME

1- S'il y a **saignement** → C.A.T. → Arrêter le saignement
2- *S'il y a **conscience** → C.A.T. → Continuer l'examen en parlant avec le blessé
*S'il y a **inconscience avec respiration** → C.A.T. → L. V. A. puis P.L.S.
*S'il y a **inconscience sans respiration** → C.A.T. → L.V. A + V. A
3- S'il y **arrêt du cœur** → C.A.T. → L. V. A + M. C. E. + V. A
4- S'il y a **fracture** → C.A.T. → immobiliser et évacuer
5- S'il y a **plaie simple** → C.A.T. → nettoyer + pansement
6- S'il y a **plaie grave** → C.A.T. → alerte + position d'attente ou EEE
7- S'il y a **brûlure** → C.A.T. → refroidir et emballer puis évacuer

C) Surveillance

Elle est faite après les soins d'urgence, le blessé installé en bonne position. Le secouriste surveille l'évolution et renouvelle régulièrement l'examen, il est attentif aux fonctions vitales : la conscience, la ventilation, la circulation, mais aussi à la température de la victime.

NB : Ne surtout pas oublier de parler avec la victime pour le réconforter.

III/ Les 10 règles du secouriste

1- Connaitre le PAS ;
2- Alerter les secours ;
3- Agir efficacement et avec calme ;
4- Classer les victimes par ordre d'urgence ;
5- Tenir la victime à 37°
6- Ne pas déplacer inutilement la victime ;
7- Ne pas jouer au médecin ;
8- Observer attentivement la victime et l'environnement ;
9- Ne pas donner à boire ;
10- Rassurer la victime ;

IV/ Boîte à pharmacie

- Avoir une boîte résistante et légère ;
- Ordre et propreté dans la boîte ;
- Remplacer les médicaments périmés ;
- Boîte hors de la portée des enfants.

COMPOSITION :

Coton - épingle de sûreté - bande adhésive – alcool – sparadrap – mercurochrome – pansement adhésif – seringue – vitamines – thermomètre – permanganate – sérum anti venin – eau oxygénée – désinfectant nasal – aspirine – baume – pommade – ciseaux – lame de rasoir – eau bouillie refroidie.

V/ Quelques notions

CAT= Conduite A Tenir
PAS= Protéger Alerter Secourir
MCE= Massage Cardiaque Externe
RCP= Réanimation Cardio- Pulmonaire
LVA= Libération des Voies Aériennes
PLS= Position Latérale de Sécurité
EEE= Emballer-Etiqueter-Evacuer
SAMU= Service d'Aide Médicale Urgente
SOS= Save Our Souls (Sauvez nos âmes)
ABC du secourisme= Allonger - Bouche à bouche - Compression

Le secourisme est un ensemble de pratiques qui doit être maitrisé et sans cesse perfectionné.

REALISE PAR : ALEXIS BARNABE DIOP
EQUIPE REGIONALE
COMMISSION FORMATION

SOURCE :

- Formation avec la Croix Rouge
- INSTRUCTION HOMMES DE TROUPE, du Groupement National des Sapeurs-Pompiers ;
- Réforme psc1 (pour les rénovations dans le secourisme) ;
- Sites de secourisme